

HENRIQUE JOSE AMARAL		* consulta R\$ 100,00
MEDICAMENTOS:		
SINTOMAS/QUEIXAS		
BANHEIRO	3X	
HORA QUE ACORDA		
HORA QUE DORME	IAH = 78.7/h 82%	
P=	127 kg	
PRATICA EXERCICIO	não faz	
HORARIO DAS REFEIÇÕES		
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE: JANTA:
17/06 - P= 6 cmH₂O Ainda estava condensando água Fuga = 21.4 diminuímos p/ 4. 1ª semana IAH = 0.3 M. de uso: 9h 35' Bem disposto e sem irritabilidade. 24/06 P= 6 cmH₂O 22 Fuga = 19.6 l/min IAH = 0.5 M. de uso: 9h 5' 2ª semana 08 P= 6 cmH₂O Banheiro 07 IAH = 0.6/h 22 Fuga = 11.1 l/min. 3ª semana Bem adaptado, s/ sonolência Teve covid 10/10 P= 6.0 cmH₂O Relata melhora 22 IAH = 0.5 da falta de ar no M. de uso: 8h 14' início. 4ª semana Fuga = 12.4 l/min TROCO Filtro 21/12 P= 6.0 22 IAH = 0.6 Fuga = 13.8 5ª semana M. de uso: 8:36' 17/02 P= 6 cmH₂O bem adaptado 2023 IAH = 0.5 (relata stress da mãe porque M. de uso = 8h 30' sugere atividade física. Fuga = 15.7 l/min		

18/04
23 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 0,5 e/h

m. de uso: 8h43'

Fuga = 4,7 l/min.

Ainda sonolento; envio relatório p/ médica p/ rever

medica/os

20/06
23 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$

m. de uso: 8h26'

IAH = 0,6 e/h

Fuga = 3,4 l/min

Relata melhora da sonolência.
Aqua ↓ rápido. *fua*{ Levodopa (50mg) ↓
mantém Quetiapina
2cp.05/09
23 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 0,7 e/h

m. de uso: 8h26'

Bem adapt., melhora da sonolência. *fua*

01/11/23

 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 0,7 e/h

m. de uso: 8h31'

fuga = 16 l/min.

- Bem adaptado } ↓ quetiapina 1 1/2 cp
} melhora sonolência
- Academia todo dia * how filho
Sina

23/01/25

 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 3,9 e/h

m. de uso: 9h51'

fuga: 0,6 l/min

Bem adaptado

* Vai fazer Biologix

Notado

24/01/25

 $P = 6$

IAH = 3,0

m. de uso: 9

{ Biologix (8,4 IDO / 0,0% Tempo)
ajuste os parâmetros
↑ $P_i = 4,6$ e $P_{max} 6,4$
fua

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologia

SERGIO

Paciente: **HENRIQUE JOSE AMARAL** (44 anos)
Convênio: **Unimed**
Matrícula: **00041010318000017**

Relatorio medico.

Paciente com roncos e SAHOS acentuada , com titulação anexa.
Necessita ajuste fino da pressão que foi titulada em 5,0 mm H2O.

São José dos Campos, 20 de maio de 2022

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologista
CRM 57.250

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
CRM 57250

SONOFIXO

bus Santa ELZA

Tel 3921 1001

Av. Mal. Floriano Peixoto, 347- 4. And Sala 402 Centro Fone: (12) 3922-5011
Cep 12210-030 São José dos Campos / SP

Nome: HENRIQUE JOSE AMARAL

Data de Nascimento: 19-9-1977

IMC: 42,93

Sexo: Masculino

Data do exame: 21-02-2022

Peso: 127 kg

Altura: 1,72 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 21-02-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 488,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 31,5 e 183,5 minutos. O tempo total de sono foi de 433,0, eficiência de 88,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 69,3%; estágio N3: 10,3%; sono REM: 18,1%. O índice de despertares foi de 55,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 78,7/hora, sendo elas 2 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 557 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 82%, permanecendo 22,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 58 - 100 bpm e NREM de 57 - 101 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (03), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 78,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=82%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (1,4/hora);
8. registro de ronco intenso durante o sono.

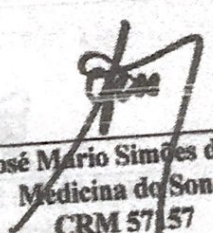
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: HENRIQUE JOSE AMARAL
Data de Nascimento: 19-9-1977
IMC: 42,93
Sexo: Masculino
Data do exame: 13-04-2022

Peso: 127 kg
Altura: 1,72 m
Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 13-04-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 465,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 87,0 e 84,5 minutos. O tempo total de sono foi de 192,5, eficiência de 41,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 54,3%; estágio N3: 29,1%; sono REM: 14,3%. O índice de despertares foi de 9,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 21,2/hora, sendo elas 3 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 65 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 87%, permanecendo 0,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 88 bpm e NREM de 53 - 87 bpm.

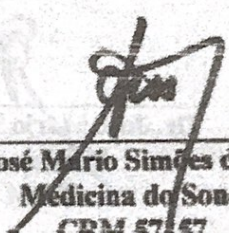
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (2), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (3,4/hora);
7. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157